



Genetik

God Bud x Black Cherry Punch



Geruch

erdig, kirschen, dunkle beeren



Geschmack

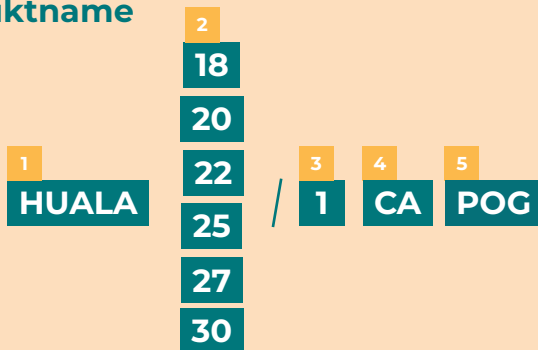
fruchtig, süß, beerig



Wirkung

analgetisch^{1,2,3}, antiinflammatorisch^{4,5}, anxiolytisch⁶, antidepressiv⁶

Produktname



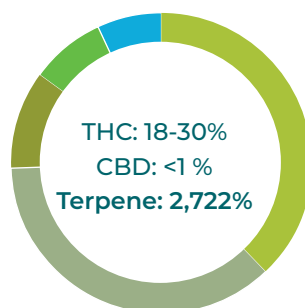
- 1 Eigenmarke
- 2 THC SOLL
- 3 CBD SOLL
- 4 Herkunft
- 5 Kultivar

Details zu Pineapple God

Pineapple God ist ein Sativa-dominanter Hybrid aus God Bud und Black Cherry Punch. Er kombiniert die erdige Tiefe von God Bud mit der fruchtigen Süße und dem Kirschprofil von Black Cherry Punch und bietet ein intensives Aroma aus Erde, dunklen Beeren und süßen Kirschen. Geschmacklich zeigt sich ein vollmundiges, fruchtig-süßes Profil mit Beerennuancen.

Je nach Dosis eignet sich Pineapple God sowohl tagsüber (Konzentration, Antrieb) als auch abends (Entspannung). Als hochwertige, unbestrahlte medizinische Blüte überzeugt er durch kontrollierte Herstellung, ausgeprägtes Aromaprofil und therapeutische Vielseitigkeit.

- 33 % Beta-Caryophyllen
- 22 % Beta-Myrcen
- 13 % Delta-Limonen
- 12 % Alpha-Humulen
- 10 % Linalool
- 10 % Sonstige



Terpene

Die dominantesten Terpene der Sorte - teilweise ausschlaggebend für den Geschmack, die Wirkung & den Geruch. Mehr Infos zu Terpenen finden Sie auf dem Datenblatt über Terpene und ihre Wirkung.

Prozentualer Anteil am Gesamtterpengehalt.
Prozentangaben sind Mittelwerte über mehrere Chargen.



Dosierungsbeispiel

Beginn mit einer niedrigen Dosis und langsamen Steigerungen, bis die gewünschte Wirkung erreicht ist.

Standard-Anfangsdosis: 25-50 mg Cannabisblüte pro Tag (ca. 6,25–12,5 mg THC bei 25 % THC)^A

Unerfahrene Patienten: 10 mg Cannabisblüte pro Tag (ca. 2,5 mg THC bei 25 % THC)^B

Produktvariationen

Produktname	PZN 5g	PZN 15g	PZN 100g
HUALA 18/1 CA POG	20275638	20275704	20276106
HUALA 20/1 CA POG	20275986	20276135	20276081
HUALA 22/1 CA POG	20276158	20275791	20275673
HUALA 25/1 CA POG	20276193	20275710	20275905
HUALA 27/1 CA POG	20276112	20275851	20276187
HUALA 30/1 CA POG	20276052	20276224	20275897

Rezeptanforderungen

- Bei Cannabis muss die **exakte** Produktbezeichnung analog der Herstellervorgabe auf dem Rezept angegeben werden.
- Weiterhin muss die **exakte** patientenindividuelle Zubereitung und Dosierung mit aufgenommen werden.

Quellennachweise

¹Klaue AL, Racz I, Pradier B, Markert A, Zimmer AM, Gertsch J, Zimmer A. The cannabinoid CB₂ receptor-selective phytocannabinoid beta-caryophyllene exerts analgesic effects in mouse models of inflammatory and neuropathic pain. Eur Neuropsychopharmacol. 2014 Apr;24(4):608-20. doi: 10.1016/j.euroneuro.2013.10.008. Epub 2013 Oct 22. PMID: 24210682.

²Katsuyama S, Mizoguchi H, Kuwahata H, Komatsu T, Nagaoka K, Nakamura H, Bagetta G, Sakurada T, Sakurada S. Involvement of peripheral cannabinoid and opioid receptors in beta-caryophyllene-induced antinociception. Eur J Pain. 2013 May;17(5):664-75. doi: 10.1002/j.1532-2149.2012.00242.x. Epub 2012 Nov 9. PMID: 23138934.

³Fidyt K, Fiedorowicz A, Strzadala L, Szumny A. beta-caryophyllene and beta-caryophyllene oxide-natural compounds of anticancer and analgesic properties. Cancer Med. 2016 Oct;5(10):3007-3017. doi: 10.1002/cam4.816. Epub 2016 Sep 30. PMID: 27696789; PMCID: PMC5083753.

⁴Irrera N, D'Ascola A, Pallio G, Bitto A, Mazzon E, Mannino F, Squadrito V, Arcoraci V, Minutoli L, Campo GM, Avenoso A, Bongiorno EB, Vaccaro M, Squadrito F, Altavilla D. beta-caryophyllene Mitigates Collagen Antibody Induced Arthritis (CAIA) in Mice Through a Cross-Talk between CB₂ and PPAR-γ Receptors. Biomolecules. 2019 Jul 31;9(8):326. doi: 10.3390/biom9080326. PMID: 31370242; PMCID: PMC6723248.

⁵Baradaran Rahimi V, Askari VR. A mechanistic review on immunomodulatory effects of selective type two cannabinoid receptor beta-caryophyllene. Biofactors. 2022 Jul;48(4):857-882. doi: 10.1002/biof.1869. Epub 2022 Jun 1. PMID: 35648433.

⁶Bahi A, Al Mansouri S, Al Memari E, Al Ameri M, Nurulain SM, Ojha S. β-Caryophyllene, a CB₂ receptor agonist produces multiple behavioral changes relevant to anxiety and depression in mice. Physiol Behav. 2014 Aug;135:119-24. doi: 10.1016/j.physbeh.2014.06.003.

^AMüller-Vahl K, Grotenhermen F. Medizinisches Cannabis: Die wichtigsten Änderungen. Deutsch Ärztebl. International 2017

^BHorlemann J, Schürmann N. DGS-Praxisleitlinie Cannabis in der Schmerzmedizin. Version: 1.0 für Fachkreise. Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. 2018

Die angegebenen medizinischen Wirkungen beziehen sich auf mögliche Effekte des dominantesten Terpens in der Blüte. Die Angaben sind lediglich ein Anhaltspunkt für die passende Produktauswahl durch das medizinische Fachpersonal und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.